

HBPM : quelle surveillance plaquettaire ?

Repères pratiques pour le dépistage d'une thrombopénie induite par l'héparine (TIH)

FICHE PRATIQUE
DOTR
Mise à jour : août 2026

À RETENIR

Le dosage des plaquettes 2 fois par semaine n'est pas systématique sous HBPM. Le rythme dépend du niveau de risque de TIH.

POUR TOUS

Numération plaquettaire de référence avant la première injection ou, à défaut, le plus tôt possible avant J4.

1. Adapter la surveillance au contexte clinique

RISQUE FAIBLE DE TIH

Pas de surveillance plaquettaire systématique

Situations typiques sous HBPM :

- contexte médical, hors cancer actif ;
- obstétrique hors chirurgie et hors césarienne ;
- traumatisme mineur ;
- traitement poursuivi au-delà d'un mois.

RISQUE INTERMÉDIAIRE DE TIH

Surveillance temporaire et ciblée

Situations typiques sous HBPM :

Postopératoire (dont césarienne), cancer actif ou traumatisme sévère.

J4 - J14

1 à 2 fois/semaine

J15 - J30

1 fois/semaine

APRÈS J30

Arrêt de la surveillance plaquettaire systématique spécifique de la TIH, car le risque devient très faible. Maintenir uniquement les contrôles justifiés par le terrain ou une autre indication clinique.

2. Suspecter une TIH sans attendre le prochain contrôle

Faire immédiatement une NFS-plaquettes et réévaluer le traitement devant :

- une nouvelle thrombose ou l'extension d'une thrombose ;
- une lésion cutanée douloureuse ou nécrotique au point d'injection ;
- une réaction allergique ou systémique après l'injection ;
- une chute des plaquettes d'au moins 50 % par rapport à la valeur initiale, même si le chiffre reste dans la norme. Une baisse confirmée de 30 à 50 % doit déjà alerter selon le RCP.

POINTS DE VIGILANCE

- Exposition à une héparine dans les 3 mois précédents : une TIH peut apparaître dès J1.
- Cette fiche concerne le dépistage de la TIH ; elle ne remplace pas les autres indications de NFS ou la surveillance du risque hémorragique.

Note : les recommandations GIHP-GFHT-SFAR sont plus allégées que certains RCP d'HBPM, qui ne sont pas tous harmonisés. Vérifier la spécialité prescrite et le protocole institutionnel.

Sources : Gruel Y. et coll., Propositions GIHP-GFHT-SFAR pour le diagnostic et la prise en charge d'une TIH, 2019 (SFTH/SFAR) ; RCP énoxaparine, Base de données publique des médicaments, consulté le 05/08/2026.